

Resumen de cierre egreso y recomendaciones

Finalidad y momento de uso

Registrar resumen de cierre egreso y recomendaciones en el momento de la actividad correspondiente a PSI-HC06. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

Usuario / profesional / fecha

Identificar de manera inequívoca el objeto o usuario del registro. En controles administrativos usar código y ubicación reservada del soporte; verificar identidad antes de decisiones clínicas o entrega.

Motivo de ingreso / periodo de atención

Registrar fecha y hora reales, periodo y secuencia cuando procede. No diligenciar retrospectivamente como si se hubiera realizado en otra fecha; las correcciones quedan trazables.

Intervenciones y evolución

Diligenciar dato concreto y pertinente a resumen de cierre egreso y recomendaciones. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Objetivos logrados / pendientes

Diligenciar dato concreto y pertinente a resumen de cierre egreso y recomendaciones. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Situación de seguridad actual

Describir hechos y condiciones relevantes, decisión y acciones tomadas. Diferenciar relato y observación; indicar ruta y responsable de seguimiento sin publicar datos sensibles en archivos administrativos.

Motivo de cierre y acuerdo

Describir resultado real, desviación y medida concreta; asignar plazo y quién verificará eficacia. No cerrar únicamente porque se redactó un plan o se pidió una reparación.

Formato para diligenciar

Documento asociado: PSI-HC06 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

Campo	Registro
Usuario / profesional / fecha	
Motivo de ingreso / periodo de atención	
Intervenciones y evolución	
Objetivos logrados / pendientes	
Situación de seguridad actual	
Motivo de cierre y acuerdo	
Recomendaciones / señales de alerta	
Ruta / contactos / remisión	
Custodia / copia / mecanismo de autoría	

Observaciones y soporte vinculado

Criterios de revisión y custodia del registro

Registro

Documentar inmediatamente, identificar usuario, fecha, hora y autoría válida. Diferenciar hechos referidos, observaciones e inferencias y explicar incertidumbre. No copiar diagnósticos ni rellenar retrospectivamente sesiones que no ocurrieron.

Integridad

Verificar consentimiento, anexos y coherencia del plan/evolución. Corregir mediante adenda con fecha y autor, conservando original. Proteger datos de terceros y material técnico de pruebas con las reglas aplicables.

Acceso

Verificar identidad y legitimación, mínimo necesario y canal seguro antes de entrega. Conservar original y constancia; revisar conservación y continuidad en caso de cierre de servicio.

Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica y reserva

Resolución 1995 de 1999, artículos 3 a 5 y 11 a 14; Resolución 839 de 2017, conservación y reglas especiales. El diseño sin casillas de firma exige asociar autoría y aceptación válidas antes del uso clínico.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Aprobó

Natalia Angel Usuga